

췌장암 진단 첫 30일

절제 가능성 · 유전자검사 · 항암 순서 이해

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 08

완전판 · 2026년 10월 개정 2판

췌장암은 ‘수술이 되느냐’를 정확히 판단하는 것에서 치료가 시작됩니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Pancreatic Adenocarcinoma, Version 4.2026 외 국내 자료(본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 책의 사용법

이 책은 처음부터 끝까지 읽는 책이 아닙니다. **지금 내 상황에 필요한 장만 펴서 쓰는 책**입니다.

지금 내 상황	먼저 펼 곳
방금 진단을 들었고 머리가 하얗다	1장 「먼저 구분하세요」 → 「진단 뒤 72시간」
몸에 이상 신호가 있다	「기다리지 않는 신호」 (응급 상자)
다음 주에 진료가 잡혀 있다	해당 치료 장 + 워크북 「진료 기록지」
검사 결과지를 받았다	PART 1의 병리·검사·병기 장
돈·보험·회사가 걱정이다	PART 5 「돈 · 서류 · 제도」
마음이 무너질 것 같다	PART 4 「마음 돌보기」
가족으로서 무엇을 해야 할지 모르겠다	PART 4 「보호자에게」

각 장의 구성은 같습니다.

- **30초 요약** — 바쁠 때는 이 상자만 읽어도 됩니다.
- **본문** — 왜 그런지, 무엇을 확인하는지.
- **오늘 물어볼 질문** — 진료실에 가져갈 질문은 장마다 3개 이내로 골랐습니다.
- **기록칸** — 들은 내용을 그 자리에서 적습니다. 보호자가 적어도 좋습니다.
- **⚠ 응급 상자** — 기다리지 말고 연락해야 하는 신호입니다.

이 책의 표시:  확정된 정보 ·  검사·결정 대기 ·  아직 모름/확인 필요.
색이 아니라 기호로 구분했으니 흑백으로 인쇄해도 그대로 쓸 수 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 병기와 절제 가능성

30초 요약

- 췌장암 치료는 **절제 가능성 4단계**로 나눠 생각합니다: **절제 가능 / 경계성 절제 가능 / 국소진행(절제 불가) / 전이성**.
- **병기(1~4기)**는 크기·림프절·전이를, **절제 가능성**은 수술이 가능한지를 말합니다. 둘은 다른 질문에 답합니다.
- **모든 췌관선암 환자에게 배선(유전) 유전자검사가 권고**됩니다. 진행·전이성은 종양 유전자검사(NGS)도 합니다.
- 경험 많은 **췌장 전문 센터의 다학제 판단**이 특히 중요한 암입니다.

절제 가능성	뜻	흔한 치료 순서
절제 가능	주요 동맥에 닿지 않고, 정맥에는 닿지 않거나 조금만 닿음(돌레의 절반 미만)	수술 → 보조항암 (고위험이면 수술 전 항암 논의)
경계성 절제 가능	혈관에 일부 닿음	수술 전 항암(± 방사선) → 재평가 → 수술
국소진행	주요 혈관을 많이 감쌈	항암 ± 방사선, 반응 좋으면 수술 재평가
전이성	간·복막·폐 등 전이	전신치료 + 증상 관리

오늘 물어볼 질문

1. 제 암은 절제 가능성 4단계 중 어디인가요?
2. 수술을 먼저 하나요, 항암을 먼저 하나요?

3. 이 병원은 체장암 다학제 진료를 하나요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자

- **열(38°C 이상)·오한 + 황달(담관염) → 해열제를 먹고 기다리지 말고 먼저 연락**
- **피를 토하거나 검은 변, 어지러움·의식 혼미(수술 후·스텐트 후 출혈 포함)**
- 심한 복통이 점점 심해짐, 계속 토함
- **수술 후 38°C 이상 발열, 배액이 탁해지거나 상처에서 고름·액체가 샘 (누출·농양 가능)**
- **심한 갈증·жа은 소변·의식 저하(고혈당) 또는 식은땀·떨림(저혈당)**
- 한쪽 다리 부종, 갑작스러운 숨참·흉통(혈전 — 체장암에서 흔함)
- 항암 중 38°C 이상 발열, 하루 4~6회 이상 설사
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 발열과 황달은 담도 스텐트가 막혀 생긴 담관염일 수 있어 빠른 치료가 필요합니다.
2. 토혈·흑변은 출혈 신호입니다.
3. 반복 구토는 십이지장이 막혔을 수 있습니다.
4. 체장암은 당뇨를 새로 만들거나 악화시킬 수 있습니다.
5. 체장암은 혈전 위험이 특히 높습니다.
6. 치료 병원이 멀면 **가까운 응급실로 먼저 가고**, 응급 카드(스텐트 종류·시술일·항암 약·마지막 투여일)를 보여 주세요.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 영상·조직검사 결과 확인 ② 췌장 전문 센터 예약 ③ 황달이 있으면 담도 배액 계획 확인.

오늘 할 일 (3개)

- ☐ CT 판독자·조직검사 결과지(아직이면 예정일)
- ☐ 췌장암 수술·항암 경험이 많은 센터 예약
- ☐ 황달(눈·피부 노랗짐, 진한 소변)이 있으면 **담도 스텐트** 계획 확인

이번 주 할 일

- ☐ 췌장 프로토콜 CT, 흉부 CT, 필요 시 MRI(작은 간 병변 확인)·PET/CT·내시경 초음파
- ☐ CA19-9 혈액검사(황달이 있으면 높게 나올 수 있어 해석 주의)
- ☐ **배선 유전자검사** 의뢰 확인(BRCA1·2, PALB2 등)
- ☐ 체중·식사량·변 상태(기름진 변) 기록
- ☐ 산정특례 신청(확진일로부터 30일 이내)

오늘 물어볼 질문

1. 절제 가능성 판단에 필요한 검사가 다 끝났나요?
2. 황달이 있다면 스텐트는 어떤 종류인가요?
3. 유전자검사는 의뢰됐나요?

4장. 검사와 조직검사

30초 요약: 조직검사에서 암세포가 보이지 않아도 **암이 없다는 뜻이 아닐 수 있습니다.** 영상과 맞지 않으면 재검사를 논의합니다. 판독지의 작은 "미확정" 결절은 곧 전이를 뜻하지 않습니다.

검사	목적
체장 프로토콜 CT	종양과 혈관 관계(절제 가능성)
흉부 CT	폐 전이
MRI	작은 간 전이 확인
내시경 초음파 + 조직검사	진단 확정
진단 복강경	작은 복막 전이 확인(일부)
CA19-9	추적 표지자(황달이 있으면 높게 나올 수 있고, 인구의 약 5~10%인 루이스 음성 체질은 암이 있어도 잘 오르지 않음)

판독지 단어장

표현	쉬운 말
abutment	혈관에 닿음(둘레의 절반 이하)
encasement	혈관을 감싸(절반 초과)
SMA, celiac, SMV/PV	수술 가능성을 가르는 주요 혈관
indeterminate nodule	미확정 결절 — 추적이 필요할 수 있음

5장. 유전자검사: 배선과 종양

30초 요약

- **배선 유전자검사**(타고난 변이): 모든 췌관선암 환자에게 권고. 결과가 **치료 선택**과 **가족 상담**에 쓰입니다.
- **종양 유전자검사(NGS)**: 먼저 **KRAS 변이 여부**를 봅니다. KRAS 변이가 없으면 드문 표적 변이(NTRK·NRG1·RET·BRAF 등)를 꼼꼼히 찾습니다. MSI(dMMR)는 KRAS 결과와 관계없이 확인합니다.
- 배선 BRCA 변이가 있는 전이성 환자는 백금 항암으로 조절된 뒤 **PARP 억제제 유지요법**을 논의할 수 있습니다(국내 허가·급여 확인 필요).

결과지 읽기

표현	뜻
germline pathogenic variant	타고난 병적 변이 → 가족 상담
VUS(의미 불명 변이)	아직 의미를 모름 — 치료·가족 검사 근거로 쓰지 않음
somatic KRAS G12D	종양에만 있는 KRAS 변이(가장 흔함)
KRAS wild-type	KRAS 정상 → 드문 표적 탐색

가족에게

변이가 확인되면 혈연 가족도 유전상담을 받을 수 있습니다. 미성년 자녀는 보통 성인이 된 뒤 본인 의사로 결정합니다.

유전 기록: 배선 _ · **KRAS** _ · MSI _ · *기타* _

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

6장. 치료 경로 지도

30초 요약

- **절제 가능:** 수술 → 보조항암(약 6개월 범위). CA19-9가 매우 높거나 종양·림프절이 크거나 체중감소·통증이 심하면 **수술 전 항암**을 먼저 논의합니다.
- **경계성:** 수술 전 항암(± 방사선) → 재평가 → 수술.
- **국소진행:** 항암 ± 방사선, 반응 좋으면 수술 재평가.
- **전이성:** 다제병용 항암(체력에 따라 강도 조절) + 증상 관리.

단계	대표 범주(국내 허가·급여 확인 필요)
보조 항암	다제병용 항암 또는 젬시타빈 기반, 체력이 약하면 젬시타빈 단독 또는 젬시타빈 +카페시타빈. S-1은 일본 연구 근거가 있으나 국내 보조요법 허가·급여는 확인 필요
수술 전 항암	다제병용 항암(± 방사선)
전이 성 1차	다제병용 항암 / 젬시타빈 + 알부민결합 파클리탁셀 등
체력 저하	부담이 적은 항암 또는 증상 조절 중심, 회복되면 다시 논의
2차 이후	1차와 다른 계열 항암, 표적(변이 시), 임상시험

단계	대표 범주(국내 허가·급여 확인 필요)
2차 이후	1차와 다른 계열 항암, 표적(변이 시), 임상시험(RAS를 겨냥한 먹는 신약이 2차 치료에서 생존을 늘린 결과가 나와 있어, 국내 도입·임상시험 여부를 물어보세요 — 최신 근거·국내 허가 확인 필요)

- 수술 전 항암 후 재평가에서 **수술 대신 항암을 이어 가거나 다른 국소치료를 검토**할 수 있습니다. 그것도 치료 계획의 일부입니다.
- 수술 전 항암을 몇 달 할 예정이면 **금속 스텐트**가 선호됩니다. 스텐트 종류와 교체 주기를 물어보세요.
- **임상시험은 첫 치료부터** 고려할 수 있는 선택지입니다.

전체 타임라인(기입식)

단계	예정 일	실 제	메모
스텐트(해당 시)			종류 :
수술 전 항암 시작			
재평가 CT			
수술			
보조항암 시작(회복이 빠르면 보통 수술 후 3개월 안 목표 — 담당의 확인)			

2주 주기 다제병용 항암 달력(일반적 예시)

날	흔한 변화	대처
1~3일	메스꺼움·설사·피로, 찬 것에 저림	처방약, 찬 음료 피하기
7~10일	백혈구 최저	발열 시 즉시 연락

날	흔한 변화	대처
11~14일	회복	걷기, 단백질

7장. 수술(회플 수술 등)

30초 요약: 채장 머리 쪽은 **채십이지장절제술(회플 수술)**, 몸통·꼬리는 **원위부 채장절제술**을 합니다. 경험 많은 센터에서의 수술이 합병증을 줄이는 데 중요합니다.

- 국내 수술 동의서에는 위를 살리는 **유문부 보존 채십이지장절제술(PPPD)**이라는 이름이 자주 나옵니다. 이 수술 뒤 합병증은 10명 중 4명 정도로 흔하지만, 가장 흔한 채장액 누출은 배액관과 금식 등으로 대개 2~3주 안에 아물고, 위가 늦게 비는 증상도 보통 1~2주 안에 나아집니다.
- 수술 후 발열, 배액 색 변화(탁함), 계속 토함·더부룩함, 출혈은 바로 연락합니다.
- 몸통·꼬리 수술(원위부 채장절제술)은 대개 비장(지라)을 함께 떼냅니다. 비장이 없으면 일부 세균 감염이 심해질 수 있어 **페렴구균·수막구균·b형 헤모필루스 인플루엔자 예방접종**을 수술 전후 알맞은 때에 맞춰야 합니다. 접종 일정을 수술 전에 확인하세요.

시기	몸	할 일
수술 후 1주	배액관, 금식→물	걷기, 통증 조절
1~2주	죽→부드러운 식사	소량 자주, 효소 복용법
1~3주	퇴원(회복·합병증에 따라 다름)	체중·혈당·배변 기록
합병증 신호	배액 색 변화(탁함), 발열, 구토·더부룩함(위배출 지연), 출혈	바로 연락

8장. 진행·전이성 췌장암

30초 요약: 통계는 많은 사람의 평균이지 나의 예언이 아닙니다. 예후가 궁금하면 **언제, 얼마나 듣고 싶은지** 먼저 말해도 됩니다. 치료 목표와 함께 **나에게 중요한 것**(가족 시간, 일, 통증 없는 생활)을 의료진과 나누세요.

나에게 중요한 것: _____

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

치료 목표를 묻는 질문

1. 이 치료의 목표는 무엇인가요? (암 크기 줄이기 / 진행 늦추기 / 증상 줄이기)
2. 치료 효과는 언제, 어떤 검사로 확인하나요?
3. 이 치료를 받지 않거나 쉬면 어떤 일이 예상되나요?

완화의료 이용하기

- 대부분의 암 병원에 **완화의료팀(자문형)**이 있습니다. 통증, 숨참, 메스꺼움, 불면, 불안 조절을 담당 교수에게 요청하면 연결됩니다.
- 호스피스·완화의료는 입원형·가정형·자문형으로 나뉘며, 지정 기관과 이용 조건은 국립암센터 중앙호스피스센터 누리집이나 병원 사회사업팀에서

확인합니다.

- 완화의료를 받는다고 해서 항암치료를 포기하는 것이 아닙니다.

미리 생각해 둘 것(원할 때만)

- **사전연명의료의향서**: 19세 이상이면 건강할 때도 작성할 수 있습니다. 보건소·지정 등록기관에서 작성하며, 언제든지 변경·철회할 수 있습니다 (국립연명의료관리기관).
- 치료를 잠시 쉬거나 멈추는 선택도 존중되는 결정입니다. 결정은 한 번에 하지 않아도 됩니다.
- 내가 직접 말하기 어려워질 때 나 대신 의견을 전할 사람을 정해 가족에게 알려 둡니다.

2차 소견과 병원 선택

30초 요약

- 2차 소견은 담당 의사를 의심하는 일이 아니라 **큰 결정을 확인하는 일**입니다. 대부분의 의사는 자연스럽게 받아들입니다.
- 2차 소견 때문에 치료를 몇 주씩 미루지 않도록 **일정을 먼저 정하고** 움직입니다.
- 가장 중요한 준비물은 병리 슬라이드·블록과 영상 CD입니다.

2차 소견이 특히 도움이 되는 경우

- 병리 결과가 드문 조직형이거나, 병원마다 해석이 갈릴 수 있다고 들었을 때
- 수술과 비수술 치료 중 선택지가 둘 이상일 때
- 기능 보존 수술이나 드문 치료처럼 경험 많은 센터가 중요한 치료일 때
- 설명을 들었는데도 결정이 서지 않을 때

병원을 고를 때 물어볼 것

1. 이 병원에서 채장암 환자를 **다학제(여러 과가 함께 보는) 진료**로 상의하나요?
2. 제게 필요한 치료(수술·방사선·항암·임상시험 등)를 **한 병원**에서 받을 수 있나요?
아니면 연계 병원이 정해져 있나요?
3. 치료 중 밤이나 휴일에 문제가 생기면 **어디로 연락**하나요?
4. 첫 치료까지 대략 몇 주가 걸리나요?

집과의 거리도 중요한 기준입니다. 매일 가야 하는 방사선치료나 잦은 외래가 예정되어 있다면, 통원 부담과 응급 시 이동 시간을 함께 따져 보세요.

2차 소견 준비 체크리스트

- ☐ 진료의뢰서(상급종합병원은 필수)
- ☐ 병리보고서 + 슬라이드/블록 대여
- ☐ 영상 CD + 판독지
- ☐ 혈액검사 결과, 복용 약 목록
- ☐ 내가 가장 궁금한 질문 3개(워크북 「질문지」)

최신 치료와 임상시험

- 임상시험은 "마지막에 기대는 실험"만이 아닙니다. 진단 초기부터 **표준치료와 함께 고려할 수 있는 선택지**입니다.
- 임상시험에 참여해도 언제든 그만둘 수 있고, 위약(가짜약)만 단독으로 쓰는 암 임상시험은 드뭅니다. 위약이 포함되면 사전에 설명을 듣습니다.
- 연구 약값은 보통 연구 쪽이 부담하지만, 교통비·추가 방문 등 부대 비용은 확인이 필요합니다.

찾는 곳

- 담당 교수에게 "제가 참여할 수 있는 임상시험이 있나요?"라고 직접 묻기 — 가장 빠릅니다.
- 한국임상시험포털(KoNECT), 식품의약품안전처 의약품안전나라 임상시험 정보, ClinicalTrials.gov(영문)

물어볼 질문

1. 이 연구는 무엇을 비교하나요? 표준치료를 받지 못하게 되나요?
 2. 방문 횟수와 검사가 얼마나 늘어나나요?
 3. 중간에 그만두면 어떤 치료를 받게 되나요?
-

PART 3. 30일 실행 로드맵

Day 0-3 · 확인하기

- ☐ 영상·조직 결과 ☐ 채장 전문 센터 ☐ 황달 시 스텐트 ☐ 응급 카드 ☐ 산정특례

Day 4-7 · 검사받기

- ☐ 채장 CT·흉부 CT·MRI ☐ CA19-9 ☐ 배선·종양 유전자검사 의뢰 ☐ 체중 기록

Day 8-14 · 결정하기

- ☐ 절제 가능성 판정 ☐ 수술 먼저 vs 항암 먼저 ☐ 임상시험 문의 ☐ 필요 시 2차 소견

Day 15-21 · 준비하기

- ☐ 포트·항암 교육 ☐ 영양 상담·채장효소 ☐ 혈당 관리 ☐ 간병 계획

Day 22-30 · 시작하기

- ☐ 첫 치료 ☐ 체중·혈당·변·통증 일지 ☐ 발열 시 연락 기준 재확인
-

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

먹는 것: 위장효소·체중·혈당

30초 요약: 기름진 변·설사·체중 감소는 소화효소 부족 신호일 수 있습니다. **위장효소제를 식사·간식과 함께** 먹으면 도움이 됩니다. 체중과 근육 유지가 치료를 버티는 힘입니다.

- 효소는 **첫 숟가락과 함께**(또는 식사 중), 양이 많은 식사는 중간에 추가. 용량은 의뢰진이 조절합니다.
- 체중을 주 2회 같은 조건에서 측정하고, 한 달에 5% 이상 줄면 알려세요.
- **마약성 진통제**는 통증 치료에 안전하게 쓰이는 약이며, 적절히 쓰면 중독 걱정이 크지 않습니다. 변비약을 함께 챙기세요. 복강신경총 차단술도 선택지입니다.
- 보호자가 "더 먹어"라고 재촉하며 갈등이 생기는 것은 흔합니다. "조금씩 자주"를 함께 목표로 삼으세요.

날짜	체중	약력/견기	식사(%)	변 상태	혈당
----	----	-------	-------	------	----

추적

- 수술 후 2년까지는 보통 3~6개월마다, 그 뒤에는 6~12개월마다 CT(또는 MRI)와 CA19-9를 확인합니다. 재발이 첫 2년 안에 많아 이 시기 검사를 빠뜨리지 않는 것이 중요합니다(담당 의뢰진 확인).

치료 중 흔한 증상, 집에서 할 일과 연락 기준

아래는 여러 암 치료에서 공통으로 흔한 증상입니다. **치료 병원의 안내가 항상 우선**이며, "연락" 칸에 해당하면 다음 예약까지 기다리지 마세요.

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
메스꺼움·구토	처방받은 구토 예방약을 시간 맞춰 (증상이 생긴 뒤가 아니라 미리). 조금씩 자주, 차갑고 냄새가 약한 음식, 생강차·크래커	하루 3회 이상 구토, 물도 못 마심, 24시간 소변이 거의 없음
피로	짧은 낮잠(30분 이내), 가벼운 걷기, 우선순위 정해 에너지 아끼기, 도움 요청	숨참·어지럼·심한 창백(빈혈 가능), 일상생활이 불가능
입안 혈음	부드러운 칫솔, 무알코올 가글(소금·베이킹소다 물), 자극적·뜨거운 음식 피하기	통증으로 먹거나 마시지 못함, 흰 반점·출혈, 발열 동반
변비	수분, 걷기, 처방 변비약. 진통제(마약성) 복용 중이면 변비약을 미리 함께	3일 이상 변이 없고 복통·구토, 배가 부풀
설사	수분·전해질(이온음료 희석, 미음), 기름진 음식·유제품·카페인 줄이기, 처방 지사제	하루 4~6회 이상, 밤에도 계속, 혈변, 어지럼·소변 감소, 면역치료 중 설사
불면	일정한 기상 시간, 낮잠 제한, 잠자리에서 휴대폰 멀리, 스테로이드는 아침 복용(지시대로)	2주 이상 계속, 불안·우울 동반
탈모	순한 샴푸, 짧은 머리, 모자·두건·가발, 두피 자외선 차단	— (대개 치료 후 다시 자람)
피부 발진·건조	순한 보습제 하루 2회 이상, 미지근한 물, 자외선 차단	물집·벗겨짐, 넓게 번짐, 점막(입·눈) 침범

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
손발 저림	찬 것 피하기(일부 약), 따뜻한 양말·장갑, 낙상 주의	단추·젓가락·걸기가 어려워짐 — 다음 투여 전에 꼭 알리기
식욕 저하·체중 감소	먹을 수 있을 때 먹기, 고단백 간식, 영양 보충 음료	한 달 5% 이상 체중 감소, 평소의 절반 이하로 1주 이상

열이 나면: 항암 중 38°C 이상(병원 기준에 따라 37.8°C 이상 1시간 지속 등)은 **해열제를 먹기 전에 먼저 연락**하는 것이 원칙입니다. 열을 내리면 감염 신호를 놓칠 수 있습니다.

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

내 마음 온도계(고통 선별)

지난 1주일 동안 내 마음의 고통은 몇 점이었나요? (0 = 전혀 없음, 10 = 극심함)

- **4점 이상**이 계속되면 다음 진료 때 점수를 그대로 말하세요. 대부분의 암 병원에는 정신건강의학과·임상심리·사회사업팀 연결 경로가 있습니다.
- 불면이 1~2주 이상 계속되면 수면 치료를 받을 수 있습니다. 잠은 치료를 견디는 체력입니다.
- 병원 밖 도움: 전국 지역암센터의 **암생존자통합지지센터**(☎ 1577-9740)에서 상담·심리지지·자기관리 프로그램을 운영합니다. 암 정보가 궁금하면 국가암지식정보센터 상담(☎ 1577-8899, 평일 9~18시)을 이용할 수 있습니다.

불안이 몰려올 때 5분 방법

1. **숨:** 4초 들이쉬고, 6초 내쉬기를 5번.
2. **이름 붙이기:** "지금 나는 ○○ 결과가 걱정된다"라고 소리 내거나 적기.
3. **내 몫 나누기:** 지금 내가 할 수 있는 일 1개(전화 1통, 서류 1장)와 의료진 몫을 나눠 적기.
4. **정보 시간 정하기:** 인터넷 검색은 하루 30분, 정해 둔 시간에만. 밤 검색은 불안을 키웁니다.

"내 탓일까?"라는 생각

암은 한 가지 원인으로 생기지 않습니다. 생활습관, 감염, 유전, 나이, 그리고 설명되지 않는 우연이 겹칩니다. **원인 찾기보다 지금부터의 계획**에 에너지를 쓰는 편이 나를 돕습니다. 가족이나 주변 사람이 원인을 따져 묻는다면 "지금은 치료 계획에 집중하고 싶어"라고 말해도 됩니다.

희망과 현실을 함께 들고 가기

통계(생존율)는 많은 사람의 평균이지 나 한 사람의 예언이 아닙니다. 궁금하다면 담당 의사에게 "제 병기와 상태에서 치료 목표가 무엇인가요?"라고 물어보세요. 듣고 싶지 않은 정보는 "지금은 듣지 않겠다"고 말할 권리도 있습니다.

보호자에게

보호자가 첫 30일에 할 수 있는 가장 좋은 일

- **기록 담당:** 진료실에서 답을 적습니다. 환자는 듣는 데 집중할 수 있습니다.
- **일정 담당:** 검사·진료·서류 일정을 한 곳(달력·앱)에 모읍니다.
- **연락 창구:** 친척·지인에게 소식을 전하는 사람을 한 명으로 정하면 환자가 같은 이야기를 반복하지 않아도 됩니다.
- **결정은 환자:** 의견은 말하되, 치료 결정의 주인은 환자입니다.

피하면 좋은 말과 바꿔 쓸 말

피하면 좋은 말	바꿔 쓸 말
"긍정적으로 생각해야 나아"	"힘든 마음 그대로 말해도 돼"
"왜 검진을 안 받았어"	"지금부터 같이 챙기자"
"○○ 먹으면 낫는데"	"새로 먹고 싶은 게 있으면 의사 선생님께 같이 물어보자"
"너보다 더 힘든 사람도 있어"	"네가 힘든 건 힘든 거야"

아이에게 알릴 때

- 아이의 나이에 맞게, **짧고 사실대로:** "(엄마·아빠·할머니 등 아이가 부르는 호칭)가 몸에 아픈 혹이 생겨서 병원에서 치료를 받을 거야."
- 아이가 자주 하는 걱정 세 가지에 먼저 답합니다: **네 탓이 아니야 / 옳은 병이 아니야 / 누가 너를 돌봐줄지 정해져 있어.**
- 학교 담임에게 알릴지, 누가 알릴지 미리 정합니다.

보호자의 휴가 제도

일하는 보호자는 **가족돌봄휴직**(연간 최대 90일)과 그 안에서 하루 단위로 쓰는 **가족돌봄휴가**(연간 최대 10일)를 회사에 신청할 수 있습니다(남녀고용평등법,

2026.10 기준·고용노동부 확인). 진료 동행이 잦은 첫 30일에 특히 유용합니다.

보호자 자신을 위해

보호자의 소진은 흔합니다. 하루 30분은 나를 위한 시간을 지키세요. 병원
사회사업팀과 환우·보호자 모임은 보호자도 이용할 수 있습니다.

직장과 일상

- **언제·누구에게·얼마나** 말할지는 내가 정합니다. 직속 상사와 인사 담당자에게 "치료 일정 때문에 근무 조정이 필요하다" 정도만 알려도 충분한 경우가 많습니다.
- 치료 일정이 나오면 **근무 조정안**(단축근무, 재택, 연차·병가 조합)을 내가 먼저 제안하면 협의가 쉬워집니다.
- 피로는 치료 중 가장 흔한 증상입니다. 치료 직후 며칠은 일을 줄이는 계획을 미리 세웁니다.
- 자영업자라면 매출보다 **현금 흐름 3개월**을 먼저 계산하고, 사회사업팀에 지원제도를 문의합니다.
- 복귀는 한 번에 100%가 아니라 단계적으로. 복귀 시점은 담당 의사와 상의합니다.
- 암생존자통합지지센터(☎ 1577-9740)에는 직장·학교 복귀를 돕는 프로그램이 있습니다(지역별 운영 확인).

먹는 것과 움직이는 것

식사 원칙

- 치료 중 목표는 "특별한 음식"이 아니라 **체중과 근육 유지**입니다. 고른 식사와 충분한 단백질(생선·달걀·두부·살코기·유제품)을 챙깁니다.

- 암 치료에 특별히 좋은 음식이나 꼭 피해야 할 "나쁜 음식"이 따로 정해져 있지는 않습니다. "좋다는 음식"만 먹거나 여러 음식을 가리면 오히려 영양이 치우치고 체력이 떨어져 치료를 버티기 어려워집니다.
- 입안이 험했을 때는 잡곡밥보다 부드러운 흰쌀밥이 나올 수 있고, 체중이 줄고 있다면 기름을 지나치게 제한할 필요도 없습니다. 유기농 식품이 치료에 특별히 도움이 된다는 근거는 뚜렷하지 않습니다.
- 체중이 한 달에 5% 이상 줄거나 먹는 양이 평소의 절반 이하로 1주 이상 이어지면 영양 상담을 요청합니다.
- 항암치료 중 면역이 떨어질 때는 날음식·덜 익힌 고기·살균 안 된 유제품을 피하라는 안내를 받을 수 있습니다. 병원 안내를 따르세요.
- **건강기능식품·한약·즙·고용량 비타민**은 항암제나 수술·방사선과 상호작용하거나 간·신장에 부담을 줄 수 있습니다. 시작 전에 꼭 의료진과 약사에게 보여 주세요.

움직이기

- 걷기처럼 가벼운 활동은 피로와 기분을 개선하는 근거가 있습니다. 컨디션에 맞춰 하루 10분부터 시작합니다.
- 일반적인 건강 목표는 주 150분 중간 강도 활동이지만, 치료 중에는 **할 수 있는 만큼**이 기준입니다.
- 발열, 심한 빈혈·어지럼, 뼈 전이 통증, 수술 직후에는 운동 강도를 의료진과 상의합니다.
- 담배는 상처 회복과 치료 효과, 다른 암 위험에 모두 영향을 줍니다. 금연 클리닉(보건소)과 금연상담전화 ☎ 1544-9030을 이용하세요.

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

- 1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
- 2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
- 3. **제도는 바뀔니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

1. 산정특례(중증질환 본인부담 경감)

항목	내용(2026.10 기준, 확인 필요)
대상	암으로 확진된 환자(체장암 포함). 상피내암(0기)·경계성 종양 등은 대상·비율이 다를 수 있어 원무과 확인
혜택	건강보험 급여 진료비의 본인부담 약 5%(입원·외래). 비급여·선별급여는 해당하지 않거나 비율이 다름
기간	적용 시작일(확진일 또는 신청일)부터 5년. 5년 뒤 남아 있는 암·재발·전이가 있으면 재등록 심사
신청 시한	확진일로부터 30일 이내 신청하면 확진일부터 적용. 그 뒤에 신청하면 신청일부터 적용
방법	진단한 의사가 산정특례 등록 신청서를 작성 → 대부분 병원 원무과가 공단에 전송. 직접 제출도 가능

확인할 것

- ☐ 병원이 대신 접수했는지, 등록 결과(문자·공단 앱)를 받았는지
- ☐ 다른 병원으로 옮겨도 산정특례는 유지됩니다. 새 병원 원무과에 등록 사실만 알리면 됩니다.
- ☐ 확진 전 검사비는 적용 시점에 따라 경감되지 않을 수 있습니다.

2. 의료비 부담을 덜어주는 제도

제도	핵심	문의
본인부담상한제	1년간 낸 건강보험 본인부담금이 소득 구간별 상한을 넘으면 남은 금액을 돌려받음(비급여 제외)	국민건강보험공단 1577-1000
재난적 의료비 지원	소득·재산 기준을 충족하고 의료비 부담이 큰 경우 일부 지원(비급여 일부 포함)	공단 지사·병원 사회사업팀
국가 암환자 의료비 지원	의료급여 수급자·차상위 등 해당자 대상 지원	주소지 보건소
병원 사회사업팀 (의료사회복지사)	후원 연계, 간병·교통·숙소 정보, 제도 신청 도움	진료 병원 사회사업팀

대상 기준과 금액은 해마다 바뀝니다. "내가 해당되는지"는 병원 사회사업팀에 한 번에 물어보는 것이 가장 빠릅니다.

3. 보험 청구 서류 체크리스트

민간 암보험(진단비)

- ☐ 진단서(질병분류코드 포함) — 보험사 양식이 있는지 먼저 확인
- ☐ 조직병리검사 결과지(병리보고서) — 대부분의 약관이 병리 확정을 요구합니다

- □ 약관에서 "**유사암·소액암**"(갑상선암, 제자리암/상피내암, 경계성 종양, 기타 피부암 등) 분류를 확인 — 진단비가 다를 수 있습니다
- □ 청구 기한(보험금 청구권 소멸시효는 3년)

실손의료보험

- □ 진료비 영수증 + 진료비 세부산정내역서(비급여 항목 확인용)
- □ 일정 금액 이상은 진단서·입퇴원확인서 추가
- □ 가입 시기에 따라 보장 범위(비급여 주사·도수 등)가 다릅니다

보험 상담에서 "진단서는 몇 통이 필요한가요?"를 먼저 물어보고, 병원에서는 한 번에 필요한 부수만큼 발급받으면 비용과 시간을 아낄 수 있습니다.

4. 회사·학교에 낼 서류

- □ 진단서 또는 소견서(치료 예정 기간 포함 여부 확인)
- □ 회사 취업규칙의 **병가·질병휴직** 조항 확인 — 법정 의무 병가는 없고 회사 규정에 따름(공무원·교원은 별도 규정)
- □ 상병수당: 일부 지역 시범사업 중 — 거주 지역·자격을 공단에 확인
- □ 개인 의료정보는 **필요한 만큼만** 알립니다. 병명 공개 범위는 내가 정합니다 (PART 4 「직장과 일상」 참고).

5. 진료 서류 모아두기(2차 소견·전원 대비)

서류	어디서	메모
병리보고서(조직검사 결과지)	진단 병원 의무기록팀	바이오마커 결과 포함 여부
병리 슬라이드·파라핀 블록 대여	진단 병원 병리과	다른 병원 재판독·추가검사에 필요. 반납 기한 확인

서류	어디서	메모
영상 CD + 판독지	진단 병원 영상의학과· 의무기록팀	CT·MRI·PET 모두
혈액검사 결과	의무기록팀	최근 것
진료의뢰서(소견서)	담당 의사	상급종합병원 외래는 의뢰서가 있어야 건강보험 적용

चे장암 참고: 질병코드는 C25입니다. 조직검사가 어렵거나 비진단적일 때
보험 진단비 청구 조건(병리 확정 요구 여부)을 약관에서 확인하세요.

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 **3개만** 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다. 1. 절제 가능성 4단계 중 어디인가요? 2. 병기는요? 3. 수술 먼저인가요, 항암 먼저인가요? 4. 배선·종양 유전자검사 결과는요? 5. 황달·스텐트 계획은요? 6. 항암 종류와 일정은요? 7. 임상시험에 참여할 수 있나요? 8. 췌장호소·영양 상담이 필요한가요? 9. 바로 연락해야 할 증상은요? 10. 치료 목표는 무엇인가요?

내 췌장암 한 장 요약

항목	내 기록
위치	머리 / 몸통 / 꼬리
병기	_____
절제 가능성	절제가능 / 경계성 / 국소진행 / 전이성
CA19-9	_____ (황달 □)
배선 / KRAS	_ / _
스텐트	없음 / 플라스틱 / 금속 (시술일 _____)
첫 치료	수술 / 수술 전 항암 / 항암
임상시험	문의 □
산정특례	□신청 □완료

오늘 꼭 물을 3가지: ① 수술이 가능한가요? ② 유전자검사 결과는? ③ 임상시험이 있나요?

응급 카드(오려서 지갑에)

이름	진단	스텐트 종류·시술일	항암 약·마지막 투여일	병원·연락처
췌장암				

같은 진단, 다른 30일 (가상 사례)

감수단 환자 페르소나를 바탕으로 재구성한 가상의 이야기입니다.

62세 종길 씨 — 경계성 절제 가능, 수술 전 항암 "수술을 먼저 안 하면 늦는 것 아니냐"가 첫 질문이었다. 담당의는 혈관 관계 그림을 그리며 수술 전 항암의 이유를 설명했다. 타임라인 표를 채우며 재평가 날짜를 기다린다. "기다리느 게 아니라 준비하는 시간이라는 걸 이해했어요."

54세 혜숙 씨 — 4기, 황달로 스텐트 열이 나던 밤, 응급 카드를 들고 가까운 응급실로 갔다. 스텐트 종류와 마지막 항암일을 보여주자 처치가 빨랐다. "해열제 먹고 기다리지 말라는 한 줄이 저를 살렸다고 생각해요."

47세 상우 씨 — 수술 후, BRCA2 변이, 딸 둘 딸들 검사 시기를 물었고, 상담사는 성인이 된 뒤 본인이 결정하도록 하자고 했다. 가족 안내문을 함께 다들었다. "제 결과가 딸들의 미래 검진 계획이 됐다는 게 위로가 됩니다."

용어사전

용어	쉬운 뜻
췌관선암	가장 흔한 췌장암

용어	쉬운 뜻
절제 가능성	수술로 뺄 수 있는지에 대한 분류
경계성 절제 가능	혈관에 일부 닿아 수술 전 치료가 필요한 단계
휘플 수술	췌장 머리·십이지장 등을 떼는 수술
담도 스텐트	막힌 담관을 여는 관
담관염	담관 감염(열+황달)
CA19-9	추적 혈액 표지자
배선 / 종양 유전자검사	타고난 변이 / 종양에만 있는 변이 검사
KRAS	췌장암에서 가장 흔한 변이 유전자
췌장효소제	소화를 돕는 효소 약
악액질	암으로 인한 체중·근육 감소

자주 묻는 질문 12

Q1. 수술을 먼저 하지 않으면 늦는 것 아닌가요? 경계성 절제 가능 췌장암에서는 수술 전 항암이 완전 절제 가능성을 높이고, 빨리 퍼지는 암을 미리 가려낼 수 있어 표준 전략입니다.

Q2. CA19-9가 많이 높으면 수술이 안 되나요? 수술 가능성은 영상의 혈관 관계로 판단합니다. 다만 매우 높으면 숨은 전이 가능성을 고려해 수술 전 항암을 먼저 논의하기도 합니다.

Q3. 황달이 있으면 항암을 못 하나요? 대부분 배액으로 빌리루빈을 낮춘 뒤 항암을 시작합니다.

Q4. 췌장효소제는 평생 먹나요? 소화 기능이 떨어진 경우 오래 먹는 경우가 많습니다. 기름진 변이 줄고 체중이 유지되면 효과가 있는 것입니다.

Q5. 당뇨가 새로 생겼어요. 췌장암이나 수술로 당뇨가 생기거나 악화될 수 있습니다. 혈당 관리 계획을 세우세요.

Q6. 마약성 진통제를 먹으면 중독되나요? 암 통증에 처방대로 쓰면 중독 걱정은 크지 않습니다. 통증이 잘 조절되어야 먹고 움직이고 잠잘 수 있습니다.

Q7. 유전자검사에서 변이가 없으면 의미가 없나요? 배선 변이가 없어도 종양 유전자검사에서 치료 단서를 찾을 수 있고, 가족에게도 "유전 위험이 높지 않다"는 정보가 됩니다.

Q8. 임상시험은 마지막에 하는 것 아닌가요? 아닙니다. 첫 치료부터 고려할 수 있습니다.

Q9. 체중이 계속 빠져요. 뭘 먹어야 하나요? 조금씩 자주, 고단백·고열량 간식, 영양 보충 음료, 효소제. 영양 상담을 요청하세요.

Q10. 휘플 수술 후 언제 일상으로 돌아가나요? 대개 수주~수개월에 걸쳐 회복하며, 보조항암 일정과 함께 조정합니다.

Q11. 가족도 췌장암 검진을 받아야 하나요? 가족 중 여러 명이 췌장암이거나 유전 변이가 확인되면 고위험 감시 프로그램을 상의할 수 있습니다.

Q12. 예후 이야기를 듣는 게 너무 두렵습니다. 듣고 싶은 만큼만, 원할 때 들어도 됩니다. "오늘은 치료 계획만 듣고 싶어요"라고 말해도 괜찮습니다.

진료실 대화법: 15분 진료를 30분처럼

30초 요약: 질문은 3개로 줄여 가져가고, 보호자가 적고, 마지막에 "제가 이해한 것이 맞는지 말해 볼게요"로 확인합니다.

진료 전날

- 질문 3개를 우선순위로 적기(워크북 W2)
- 지난 진료 이후 바뀐 증상·약을 한 줄씩

- 검사 결과지·영상 CD·복용 약 목록 챙기기

진료실에서

1. **첫 문장으로 가장 중요한 것부터:** "오늘 가장 궁금한 건 첫 치료가 무엇이고 언제 시작하는지예요."
2. 어려운 말이 나오면: "그 말을 쉽게 다시 설명해 주시겠어요?" "종이에 적어 주실 수 있나요?"
3. 선택지가 나오면: "선택지마다 장점과 단점, 그리고 선생님이라면 무엇을 고르실지 여쭙봐도 될까요?"
4. 끝나기 전: "제가 이해한 대로 말해 볼게요. ○○하고, 다음은 ○월 ○일 ○○ 검사죠?"
5. 연락처: "집에서 문제가 생기면 누구에게 연락하나요?"

녹음하고 싶다면

진료 내용을 기억하기 위해 녹음하고 싶을 때는 **먼저 의료진에게 양해를 구하세요.**
허락이 어려우면 보호자 기록으로 대신합니다.

다학제 진료

여러 과(수술·종양내과·방사선종양학과·영상의학과·병리과 등)가 한자리에서 치료를 상의하는 진료입니다. 치료 선택지가 여럿이거나 순서가 중요한 경우 "다학제 진료를 받을 수 있나요?"라고 물어보세요.

검사 준비 카드

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
CT(조영)	몇 시간 금식(병원 지시), 물 충분히(제한 없을 때)	조영제 알레르기, 신장 기능 저하, 당뇨약 (메트포르민), 임신 가능성	촬영은 10~20분

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
MRI	금속 제거, 일부는 금식	심박동기·인공와우·몸속 금속, 폐소공포증(진정 상담), 신장 기능	30~60분
PET/CT	(FDG PET) 4~6시간 금식, 전날 격한 운동 피하기 · 다른 종류의 PET은 병원 안내	당뇨(혈당 조절법 미리 확인), 임신·수유	주사 후 대기 포함 2~3시간
조직검사 (바늘)	금식 여부 확인	혈액을 묽게 하는 약(중단 여부는 의료진 지시), 알레르기	시술 후 관찰 수시간
내시경	금식, 대장은 장 정결제	혈액을 묽게 하는 약, 당뇨약	진정 시 보호자 동행·당일 운전 금지
뼈스캔	주사 후 물 많이 마시기	임신·수유	주사 후 2~4시간 대기

검사 결과는 "검사를 한 날"이 아니라 **"결과 설명을 듣는 날"**을 미리 예약해 두면 기다리는 불안이 줄어듭니다.

워크북

이 장은 오려 쓰거나 복사해 쓰도록 만들었습니다. 진료실에는 이 페이지만 들고 가도 됩니다.

W1. 비상 연락처 카드 (휴대폰 사진으로도 저장)

항목	기록
담당 교수 / 진료과	
평일 진료실·외래 간호사실 ☎	
야간·휴일 연락처 ☎	
가까운 응급실(치료 병원 우선)	
항암·방사선 치료실 ☎	
보호자 1 / 보호자 2 ☎	
국가암지식정보센터 암정보 상담(평일 9~18시)	☎ 1577-8899
암생존자통합지지센터(지역암센터)	☎ 1577-9740
응급 119 · 정신건강 위기 109	

W2. 진료 기록지 (진료마다 1장)

항목	기록
날짜 / 진료과 / 의사	
오늘 들은 진단·병기	✓ / ⏳ / ?
오늘 결정된 것	
다음 검사·날짜	
다음 진료 날짜	
새로 받은 약	
꼭 지켜야 할 주의사항	

항목	기록
다음에 물어볼 것	

W3. 7일 증상 일지

날 짜	체온 (최고)	통증 0~10	식사(평소의 %)	배변· 배뇨	잠	기분 0~10	메모·연락 여부

W4. 복용 약·보충제 목록 (모든 진료에 지참)

이름	용량·횟수	왜 먹나	처방한 곳	의료진에 알림
				☐
				☐
				☐
				☐

혈액을 묽게 하는 약(항응고제·항혈소판제), 당뇨약, 한약·건강기능식품은
수술·시술·항암 전에 특히 중요합니다.

W5. 30일 체크 달력

주	날짜	한 일(✅) / 남은 일(🕒)
1주(Day 0-7)		

주	날짜	한 일(✅) / 남은 일(⌚)
2주(Day 8-14)		
3주(Day 15-21)		
4주(Day 22-30)		

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Pancreatic Adenocarcinoma, Version 4.2026. NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 췌장암 정보, 한국췌장외과연구회·대한췌담도학회 자료, 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 실지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **참고문헌:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터, 췌장암 정보(확인일 2026.10.04). 사실 확인용 참고문헌이며, 국가암지식정보센터의 저작물을 수록하지 않았습니다. 독자 안내: 공식 암 정보와 무료 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899.
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.
- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.

- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
 - 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.
-

ApuDa | 아프지만, 다행이다. · <https://apuda.app/>